Паспорт препарата Зоресан 25 мг, 50 мг и 100 мг

1. **Состав (действующее вещество), форма выпуска, дозы:** зонисамид таблетки 25 мг, 50 мг и 100 мг № 30.
2. **Фармакотерапевтическая группа:** Противоэпилептические средства, прочие противоэпилептические средства. Код АТХ N03A X15.

3. **Целевая группа врачей и показания**:

№	СПЕЦИАЛЬНОСТЬ	ПОКАЗАНИЯ	ФОРМА ВЫПУСКА И ДОЗА ПРЕПАРАТА
1	Неврологи	**Эпилепсия.** Взрослые и дети в возрасте от 6 лет: Монотерапия у взрослых пациентов с парциальными эпилептическими приступами с вторичной генерализацией или без, с впервые диагностированной эпилепсией; Дополнительная терапия у взрослых и детей в возрасте от 6 лет с парциальными эпилептическими приступами с вторичной генерализацией или без. **Болезнь Паркинсона*.** Лечения двигательных симптомов болезни Паркинсона, как дополнение к леводопе.	Зоресан 25 мг, 50 мг и 100 мг №30
2	Психиатры	**Эпилепсия.** Взрослые и дети в возрасте от 6 лет: Монотерапия у взрослых пациентов с парциальными эпилептическими приступами с вторичной генерализацией или без, с впервые диагностированной эпилепсией; Дополнительная терапия у взрослых и детей в возрасте от 6 лет с парциальными эпилептическими приступами с вторичной генерализацией или без.	Зоресан 25 мг, 50 мг и 100 мг №30
3	Нейрохирурги	Для снятия судорожной готовности/активности в посттравматический период и в период реабилитации/ симптоматические, фокальные эпилепсии.	Зоресан 25 мг, 50 мг и 100 мг №30
4	Эпилептологи	**Эпилепсия.** Взрослые и дети в возрасте от 6 лет: Монотерапия у взрослых пациентов с парциальными эпилептическими приступами с вторичной генерализацией или без, с впервые диагностированной	Зоресан 25 мг, 50 мг и 100 мг №30

		эпилепсией; Дополнительная терапия у взрослых и детей в возрасте от 6 лет с парциальными эпилептическими приступами с вторичной генерализацией или без.	

* Показания к применению off label

1. **Основные схемы лечения:**

<table>
<tr><th>№</th><th>Показание согласно инструкции*</th><th>Длительность терапии</th><th>Доза и кратность приема</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Эпилепсия у взрослых.

Монотерапия взрослых пациентов с парциальными эпилептическими приступами с вторичной генерализацией или без, с впервые диагностированной эпилепсией;

Дополнительная терапия у взрослых с парциальными эпилептическими приступами с вторичной генерализацией или без.</td><td>длительно</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">РЕЖИМ ЛЕЧЕНИЯ</th><th colspan="3">ФАЗА ТИТРОВАНИЯ ДОЗЫ</th><th rowspan="2">ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДОЗА</th></tr>
<tr><th>1-2 НЕДЕЛЯ</th><th>3-4 НЕДЕЛЯ</th><th>5-6 НЕДЕЛЯ</th></tr>
<tr><td>Монотерапия
Взрослые с впервые диагностированной эпилепсией</td><td>100 мг/сутки (1 раз в сутки)</td><td>200 мг/сутки (1 раз в сутки)</td><td>300 мг/сутки (1 раз в сутки)</td><td>300 мг/сутки (1 раз в сутки) Если нужны более высокие дозы: увеличивать на 100 мг с двух-недельными интервалами до максимальной рекомендуемой дозы 500 мг / сутки</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Дополнительная терапия
- с лекарственными средствами, индуцирующими изофермент CYP3A4</td><td>1 НЕДЕЛЯ</td><td>2 НЕДЕЛЯ</td><td>3-5 НЕДЕЛЯ</td><td rowspan="2">300-500 мг/сутки (в 1 или 2 приема)</td></tr>
<tr><td>50 мг/сутки (в 2 приема)</td><td>100 мг/сутки (в 2 приема)</td><td>Увеличение на 100 мг с недельными интервалами</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Дополнительная терапия
- без лекарственных средств, индуцирующих изофермент CYP3A4 или пациенты с почечной или печеночной недостаточностью</td><td>1 НЕДЕЛЯ</td><td>3-4 НЕДЕЛЯ</td><td>5-10 НЕДЕЛЯ</td><td rowspan="2">300-500 мг / сут (в 1 или 2 приема). Некоторые пациенты могут реагировать на более низкие дозы.</td></tr>
<tr><td>50 мг/сутки (в 2 приема)</td><td>100 мг/сутки (в 2 приема)</td><td>Увеличение на 100 мг с недельными интервалами</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2</td>
<td>Эпилепсия у детей.

Дополнительная терапия у детей в возрасте от 6 лет с парциальными эпилептическими приступами с вторичной генерализацией или без.</td>
<td>длительно</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">РЕЖИМ ЛЕЧЕНИЯ</th><th colspan="2">ФАЗА ТИТРОВАНИЯ ДОЗЫ</th><th colspan="2">ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДОЗА</th></tr>
<tr><th>1 НЕДЕЛЯ</th><th>2-8 НЕДЕЛЯ</th><th>Пациенты с массой тела от 20 до 55 кг*</th><th>Пациенты з массой тела> 55 кг</th></tr>
<tr><td><u>Дополнительная терапия
- с лекарственными средствами, индуцирующими изофермент CYP3A5</u></td><td>1 мг/кг/сутки (1 раз в сутки)</td><td>Увеличение на 1 мг/кг с недельными интервалами</td><td>6–8 мг/кг/сутки (1 раз в сутки)</td><td>300-500 мг/сутки (1 раз в сутки)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Дополнительная терапия
- без лекарственных средств, индуцирующих изофермент CYP3A4 или пациенты с почечной или печеночной недостаточностью</td><th>1-2 НЕДЕЛЯ</th><th>≥3 НЕДЕЛЬ</th><th>Пациенты с массой тела от 20 до 55 кг*</th><th>Пациенты з массой тела> 55 кг</th></tr>
<tr><td>1 мг/кг/сутки (1 раз в сутки)</td><td>Увеличение на 1 мг/кг с недельными интервалами</td><td>6–8 мг/кг/сутки (1 раз в сутки)</td><td>300-500 мг/сутки (1 раз в сутки)</td></tr>
</table>
У детей зонисамид может вызвать снижение потоотделения и перегревания, что при отсутствии соответствующей помощи может привести к поражению головного мозга и летальному исходу. Дети относятся к пациентам высокого риска, особенно в условиях жаркой погоды.
Если ребенок принимает зонисамид, необходимо придерживаться следующих правил:

Следует избегать перегревания, особенно в жаркую погоду;
Следует избегать значительной физической нагрузки, особенно в жаркую погоду;
Следует потреблять большое количество холодной воды
Не следует применять следующие препараты: ингибиторы карбоангидразы (такие как топирамат и ацетазоламид) и антихолинергические препараты (такие как кломипрамин, гидроксизин, дифенгидрамин, галоперидол, имипрамин и оксибутинин).

</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Болезнь Паркинсона**

Лечение двигательных симптомов болезни</td>
<td>длительно</td>
<td>Дозировка от 25 мг до 100 согласно схеме титрации в качестве дополнительной терапии без лекарственных средств, индуцирующих изофермент CYP3A4</td>
</tr>
</table>

	Паркинсона, как дополнение к леводопе.		

* Показания к применению согласно утвержденной МОЗ инструкции препарата

** Показания к применению off label

2. **Возможные комбинации с другими препаратами Кусум**

№	Возможная комбинация	Показание	Примечание
1	Зоресан 50 мг (начальная доза при комбинированной терапии) + Мезакар 200 мг (Мезакар SR)	Комбинированная терапия эпилепсии в том числе резистентных форм	Стартовая доза зонисамида в комбинации с карбамазепином составляет 50 мг в 2 приема (карбамазепин индуцирует изофермент CYP3A4)
2	Зоресан 50 мг (начальная доза при комбинированной терапии) + Оксапин 200 мг	Комбинированная терапия эпилепсии в том числе резистентных форм. Если Оксапин назначен в качестве стартовой терапии.	Стартовая доза зонисамида в комбинации составляет 50 мг в 2 приема.
3	Зоресан 50 мг (начальная доза при комбинированной терапии) + Логуфен 500 мг	Комбинированная терапия эпилепсии в том числе резистентных форм	Стартовая доза зонисамида в комбинации составляет 50 мг в 2 приема.
4	Зоресан 50 мг (начальная доза при комбинированной терапии) + Ланистор 100 мг	Комбинированная терапия эпилепсии в том числе резистентных форм	Стартовая доза зонисамида в комбинации составляет 50 мг в 2 приема.
5	Зоресан 25 мг + Конфундус (леводопа+карбидопа) Зоресан 25 + Конфундус трио (карбидопа+леводопа+энтакапон)	Лечение двигательных симптомов болезни Паркинсона, как дополнение к леводопе.	Дозировка от 25 мг до 100 согласно схеме титрации в качестве дополнительной терапии без лекарственных средств, индуцирующих изофермент CYP3A4

3. **Противопоказания к назначению препарата:**

Повышенная чувствительность к действующему веществу, к любому из вспомогательных веществ или сульфонамидам.

4. **Основные побочные эффекты и частота их возникновения**

Инфекции и инвазии: пневмония, урогенитальные инфекции.
Со стороны крови и лимфатической системы: экхимозы, агранулоцитоз, апластическая анемия, лейкоцитоз, лейкопения, лимфаденопатия, панцитопения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, медикаментозно-обусловленный сидром повышенной чувствительности, DRESS-синдром (сыпь с эозинофилией и системными симптомами).
Со стороны метаболизма: анорексия, снижение аппетита, гипокалиемия, метаболический ацидоз, почечный тубулярный ацидоз.
Со стороны психики: возбуждение, раздражительность, спутанность сознания, депрессия, эмоциональная лабильность, перепады настроения, острый психоз, тревожность, бессонница, психотические расстройства, гнев, злость, суицидальные мысли и попытки самоубийства, галлюцинации.
Со стороны нервной системы: атаксия, головокружение, нарушение памяти, сонливость, брадифрения (заторможенность мышления), нарушения внимания, нистагм, парестезии, нарушения речи, тремор, судороги, амнезия, кома, большие эпилептические припадки, миастенический синдром, злокачественный нейролептический синдром , эпилептический статус.
Со стороны органа зрения: диплопия, глаукома, боль в глазах, миопия, нечеткость зрения, снижение остроты зрения.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка, аспирационная пневмония, нарушение дыхания, пневмонит, связанный с повышенной чувствительностью.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: боль в животе, запор, диарея, диспепсия, тошнота, рвота, панкреатит.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: холецистит, холелитиаз, гепатоцеллюлярной повреждения.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, алопеция, ангидроз, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: рабдомиолиз.
Со стороны мочевыделительной системы: нефролитиаз, уролитиаз, гидронефроз, почечная недостаточность, нарушения состава мочи.
Общие нарушения и реакции в месте введения: повышенная утомляемость, гриппоподобные состояния, повышение температуры тела, периферические отеки.
Лабораторные показатели: снижение уровня бикарбонатов, снижение массы тела, повышение уровня КФК, повышение уровня креатинина, повышение уровня мочевины, нарушение биохимических показателей функции печени.
Другие: тепловой удар.

5. **Основные конкуренты:**

Препараты с действующим веществом зонисамид на рынке Украины отсутствуют.

6. **СПВВ по препарату:**

СВОЙСТВО	ПРЕИМУЩЕСТВО	ВЫГОДА ДЛЯ ВРАЧА	ВЫГОДА ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Зонисамид	Многокомпонентный механизм действия - ингибирует ионные каналы нескольких типов: блокирует стойкие повторяющиеся высокочастотные разряды вольтаж-зависимых Na каналов (изменяя пороговое значение для быстрой инактивации каналов этого типа) уменьшает ионные потоки через низкопороговые Ca каналы Т-типа (не оказывая влияния на Ca каналы L-типа), таким образом препятствуя распространению эпилептических разрядов в нейронах.	Эффективность в резистентных к терапии случаях. Широкий спектр применения при всех основных формах эпилепсий и типах эпилептических припадков. Эффективность в отношении парциальных, вторично генерализованных припадков.	Возможность продолжить консервативную терапию и контролировать приступы, не прибегая к хирургическим методам лечения
Зонисамид	В рекомендациях Международной противоэпилептической лиги (ILAE) от 2013 г. зонисамид в настоящее время отнесен к уровню доказательности А по эффективности в монотерапии фокальных приступов у взрослых	Следование международным рекомендациям, уверенность в успехе и эффективности лечения	Эффективная проверенная терапия фокальных приступов эпилепсии.
Зонисамид	Обладает защитными свойствами против воздействия свободных радикалов.	Нейропротекторные свойства. Предотвращение гибель нейронов в результате рецидивирующих приступов в эксперименте	Отсутствие негативного влияния на внимание, активность и др. когнитивные функции.
Зонисамид	Время достижения пиковой концентрации Cmax в сыворотке или плазме крови достигается в течение	Быстрый эффект	Бытрый эффект от терапии

	2-5 часов после приема.		
Зонисамид	Абсолютная биодоступность около 100 %, не зависит от према пищи	Быстрый эффект, отсутствие взаимодействий с пищей	Быстрый эффект, отсутствие взаимодействий с пищей, можно принимать не зависимо от приема пищи
Зонисамид	Линейная фармакокинетика	Простой режим дозирования и подбора дозы	Простой режим дозирования и подбора дозы
Зонисамид	Период полувыведения около 60 часов (при условии отсутствия одновременного приема индукторов активности изофермента CYP3A4). Период полувыведения не зависит от дозы и повторного введения.	Позволяет принимать препарат один раз в сутки	Удобство терапии и комплаентность даже в случае комбинированной терапии
Зонисамид	Не индуцирует свой собственный метаболизм.	При длительном приеме концентрация остается такой же, как и в начале приема, коррекции дозы не требуется.	Уверенность в эффекте лечения, нет необходимости постоянно повышать дозу, в связи с этим меньше побочных эффектов, доверие лечащему врачу, готовность следовать его рекомендациям.
Зонисамид	Возможность применения в лечении двигательных симптомов болезни Паркинсона, как дополнение к леводопе.	Оптимизация леводопа терапии Пациентов с болезнью Паркинсона увеличение их двигательной активности и качества жизни.	Сокращение продложительности периода «выключения» - больше двигательной активности, лучшее качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона
Доступная цена препарата	Лечение доступно широкому кругу пациентов	Гарантированное оказание помощи пациентам различных социальных групп, в том числе в случае необходимости	Доступность терапии для различных слоев населения (покупательская способность), в том числе в случае необходимости

		комбинированной терапии эпилепсии.	комбинированной терапии эпилепсии.